

서형 관령 코멘트



기분 변화 증례의 경우 환자가 주요 우울 증상 기준에 해당되는 증상을 보여 가족 손에 이끌려 병원에 온 경우가 있습니다. **본인이 원해서 내원했는지 물어보고 본인 의지로 병원에 온 경우가 아닌 경우 본인은 본인의 상태에 대해 어떻게 생각하는지, 몸이 불편하지 않은지 물어보는 것이 좋습니다.** 기분 변화가 정신과적 원인인지, 기질적 원인인지를 감별하는 것이 필요합니다. 정신과적 원인의 경우 단극성 우울과 양극성 관련 장애를 포함한 기분장애와 스트레스 관련 원인(적응장애, 애도 반응), 기타 정신 질환(조현병 등)을 의심해야 하며, 기질적 원인의 경우 약물 과거력을 살펴 물질 사용 및 금단 증상과 그 외 신체 질환을(심혈관, 내분비, 암, 중추신경계) 감별해야 합니다.

병력 청취 시 병전 성격이 어땠는지를 확인하며, **큰 스트레스 요인**이 있진 않았는지를 확인해야 합니다. 기분 변화가 나타나는 유발 상황이나 악화 요인이 무엇인지를 물어야 합니다. 예를 들어, 폐경 여성의 경우 폐경 이후 우울증이 심해집니다. **기분장애 증상 뿐만 아니라 정신과적 증상과 인지장애 증상 여부에 대해서도 반드시 물어야 합니다.** 특히 **과거 또는 현재 자살 사고, 계획, 시도가 있었는지는 꼭 물어봐야 합니다.** 우울 증상을 일으킬 수 있는 다이어트 약, 경구 피임약 등 약물 복용력과 음주 여부를 확인해 물질 사용 장애를 감별합니다.

신체 진찰 시 기질적 원인을 감별하기 위해 맥박/혈압 확인, 갑상샘 시진/촉진, 심음과 호흡음 청진, 하지 오목 부종 확인, 뇌졸중 등으로 팔다리 근력, 감각 이상이 있지는 않은지를 확인해야 합니다.

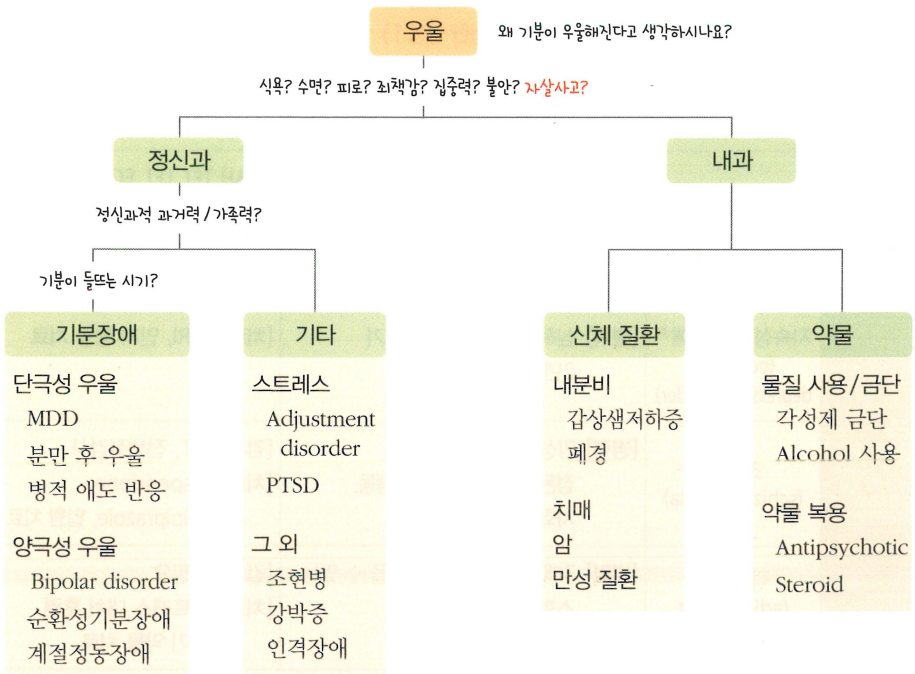
환자 교육에서 **응급 상황으로 자살 위험성이 높거나 정신과적 증상을 동반하거나 우울증이 심할 경우 입원의 필요성을 설명하고 권고하는 것이 중요합니다.** 또한 환자가 느끼는 기분 변화에 대해 **안심시키고 공감하면서 꾸준히 치료 받으면 좋아질 것이라는 암시와 지지의 방법으로 교육하는 것이 중요하겠습니다.** 약물 치료와 정신 치료 두 가지 측면에서 치료 방법을 설명하는 것이 좋고, 이 외에도 가벼운 운동과 스트레스 회피, 금주가 필요함을 교육해야 합니다. 약물 치료의 경우 환자가 약물 치료에 대해 거부감이 없도록 부작용에 대해 설명하고, 약물의 효과가 나타나기 위해서 최소 6개월 이상 지속적인 복용이 필요하다는 것을 꼭 설명하면 좋을 듯 합니다.

계통	질병	진단 키워드	검사/치료
원발성	주요 우울장애★ (major depressive disorder)	[병력] 2주 이상 주요 우울 삽화만 존재 - 우울 - 의욕 저하 - 식욕 부진 - 수면장애 - 피로 - 죄책감 - 사고력장애 - 정신 운동 초조 - 자살 사고	[검사] Beck의 우울척도검사 (Beck depression inventory) [치료] SSRI, Tricyclic antidepressant, 정신사회적 치료, 자살 위험 시 입원, 전기경련요법(ECT)
	양극성 장애 I형★ (bipolar disorder)	[병력] 조증 삽화 1번이라도+1주 이상 (자존심 ↑, 수면 감소, 말 ↑, 사고비약, 주위산만, 목적 지향적 활동 ↑, 위험한 행동 ↑)	[검사] TFT, LFT, ECG, BUN/Cr [치료] Lithium, Valproate, lamotrigine, 인지 행동 치료, 입원 치료
	양극성 장애 II형★	[병력] 경조증 삽화 + 4일 이상 (명확한 기능의 변화, 심하지 않음)	
	순환기분장애★ (cyclothymia)	[병력] 2년 이상 주요 우울장애 기준에 미치지 못하는 우울과 경조증 삽화의 반복	[검사] TFT, LFT, ECG, BUN/Cr [치료] Lithium, Carbamazepine, Valproate
	지속성 우울장애★ (persistent depressive disorder)	[병력] 심하지 않은 우울 정도가 2년 이상 지속	[치료] SSRI, 인지 행동 치료
	조현병 (schizophrenia)	[병력] 망상, 환시/환청, 정돈되지 않은 말이나 행동, 사회적 고립	[검사] TFT, 전해질검사 [치료] Risperidone, Aripiprazole, 입원 치료
	적응장애 (adjustment disorder)	[병력] 3개월 이내 누구나 겪을 수 있는 스트레스에 반응	[검사] 불필요 [치료] 스트레스 대처 훈련, 단기 약물 치료

원발성	소아/청소년기 우울증	[병력] MDD와 유사하지만, 소아에서는 과민, 집중력 감소, 식욕 감소로 인한 성장장애 등으로 표현됨	[검사] 청소년 우울증 선별검사 (PHQ-9 modified for adolescent) [치료] 약물 치료 : SSRI 정신 치료 : 인지 행동 치료, 대인정신요법
속발성	갑상샘저하증 (hypothyroidism)	[병력] 추위불내성, 의욕 저하, 체중 증가 [검진] 갑상샘 촉진 시 갑상샘 비대	[검사] TFT [치료] Levothyroxine
	약물 유발 우울증	[병력] 알코올/스테로이드/항정신병약	[검사] 약물 중단 후 확인 [치료] 약물 중단 또는 변경
	뇌졸중 (stroke)	[병력] 여러 마비 소견 및 국소 신경학적 이상 소견	[검사] 뇌 CT/MRI, 혈관조영술 [치료] 혈전용해제, 재활 치료

* 기분저하증(dysthymia)은 DSM-5에서 지속성 우울장애(Persistent depressive disorder)로 변경

증례별 알고리즘



기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

O	언제부터 기분이 가라앉기 시작했나요?
L	-
D	하루 중 얼마나 오래 기분이 가라앉나요?
Co	하루 종일 우울한가요?/기분이 중간에 변하나요?
Ex	이전에도 이런 적이 있었나요? 환자 : 네, 고등학교 입학한 이후에도 그랬어요 → 특별한 사건이 있었나요?/치료를 받았었나요? [병전 성격] 기분 변화가 있기 전 환자분의 평소 성격은 어땠나요?
C	[정도] 기분 변화가 얼마나 심하신가요?/일상 생활에 문제를 많이 끼쳤나요?
A	[주요 우울장애] 하루/살이가 자다가/정신 차리고 살(체중 or 식욕) 꺼려고 피/자/사묵자 하루 종일 우울한 기분 → 우울한 기분이 하루 종일 지속되나요? 의욕 저하 → 평소 관심을 갖던 일에도 흥미가 없어지셨나요? 체중 변화/식욕 변화 → 입맛은 좀 어떠세요?/식사는 잘 하시나요? 불면증 → 잠은 잘 주무시나요? 피로 → 몸에 힘이 없고 많이 피로하십니까? 불안/초조 → 매사에 불안하고 초조함을 느끼진 않으시나요? 죄책감 → 자신이 쓸모없는 존재라는 생각이 드시나요? 집중력 저하 → 집중은 잘 되시나요?/건망증이 심해지진 않으셨나요? 자살 사고/계획/시도 여부 → 자살을 생각하시나요?/계획을 세웠나요?/시도한 적 있나요? [양극성 장애] 조증 삽화(기분, 수면, 충동) → 기분이 들떠서 무엇이든 할 수 있을 것 같은 기분이 드신 적이 있나요? 잠을 안자도 하나도 피곤하지 않은 적이 있나요? 충동적으로 일을 벌이거나, 충동구매를 한 적이 있나요? 암기법 기수(잠)충 설명 DIGFAST: Distractibility - Irresponsibility - Grandiosity - Flight of idea - Activity - Sleeplessness - Talkativeness [조현병] 환청/환시 → 다른 사람들에게 보이지 않는 것이 보이거나 들리진 않나요? 망상적 사고 → 누군가 자신을 모함하거나 해를 끼치려 한다는 생각이 드나요? [기질적 장애] 지금 신체적으로 불편하신 곳이 있으신가요? (갑상샘) 이전보다 추위를 더 많이 타나요?/땀이 났지는 않았나요?/체중 변화 (뇌졸중) 팔다리에 힘이 빠지나요?

F	[계절 정동] 계절적으로 기분 변화가 심해지는 시기가 있나요?
	[분만 후 우울증] 최근 출산을 하셨나요?/출산 후 우울증은 없으신가요?
	[적응, 외상 후] 최근 6개월 내에 특별한 스트레스가 있었나요? (지인의 죽음/본인의 심한 질환/누구나 경험할 수 있는 사건 등)
	[스트레스] 스트레스를 많이 받으시는 편이신가요?
E	-
외	이전에 수술 받으신 적 있나요?
과	진단 받은 질병이 있으신가요? (만성 질환/암/뇌졸중/다른 정신과 질환)
약	현재 복용 중인 약물이 있나요? (스테로이드) 과거 약물을 많이 사용하셨었나요? (R/O 물질 오남용)
사	술을 드시나요? (R/O 알코올 사용장애)/담배를 하시나요? 운동은 꾸준히 하시나요?/직업은 어떻게 되시나요?
가	[가족 관계] 가족 관계는 어떠신가요?/가족 간에 무슨 문제는 없나요? 가족들 중에 정신건강의학과 치료를 받으신 분이 있나요?
여	[월경] 월경은 규칙적으로 하시나요? or 폐경하셨나요? 기분 변화가 월경/폐경과 연관이 있나요? [월경전증후군 및 월경전불쾌감장애] 기분 변화(e.g. 불안, 우울, 긴장 등)가 월경 전에 심했 다가 월경이 시작하거나 끝나면 호전되나요? 갑자기 울고 싶거나 슬퍼진다가거나 거절에 대해 민감해지셨나요? 대인 관계에서의 갈등이 증가하지는 않았나요? 유방의 압통이나 부종, 두통, 관절통 혹은 복통 등이 기분 변화 전후로 생기지 않았나요?
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기). [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈), 공막(황달) 2. 목★ : 갑상샘 촉진 3. 가슴 : 심음 청진/호흡음 청진 4. 피부 : 하지 오목 부종★(pitting edema) [침대에 앉아서] 5. 팔다리★ : 감각/근력/DTR → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 점은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	기분이 우울한 것 때문에 많이 힘드셨을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 흔히 우울증이라고 부르는 주요 우울장애가 가장 의심됩니다.
감별 진단	하지만 그 외에 양극성 장애를 배제할 수 없고 갑상샘저하증 등에 대해서도 검사가 필요합니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 우울증 척도검사, 갑상샘기능검사, 전체혈구검사를 해보도록 하겠습니다. 괜찮으신가요?
치료	[주요 우울장애] 만약 검사로 우울증이 확진되면 항우울제 치료를 하게 됩니다. 약물 치료 시 중독같은 부작용은 없기 때문에 안심하셔도 됩니다. 항우울제는 투여 2~3주 후에 효과가 나타나기 시작하기 때문에 최소 6개월 이상 지속적으로 약물을 복용하시는 것이 중요합니다. [양극성 장애] 만약 검사로 양극성 장애가 확진되면 기분조절제라는 기분을 일정하게 유지되도록 해주는 약물을 처방해 드릴텐데, 재발방지를 위해서 장기간 복용하는 것이 매우 중요해서 환자분의 협조가 필요합니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전될 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	[응급] [자살 위험성] 환자분께서 자살 사고/계획/시도가 있으셨던 분으로 자살 위험성이 높습니다. 환자분의 안전을 위해 입원 치료가 필요합니다. [정신과적 증상 동반] 환자분과 타인의 안전을 위해서 입원 치료가 필요합니다. [운동 권고] 낮에 햇빛을 받으면서 가벼운 운동, 걷기, 요가 등의 운동이 부정적 기분을 호전시킬 수 있습니다. [스트레스 해소] 스트레스 요인을 피하고, 긍정적인 인지 체계를 건설하며, 건강한 해소 방법을 갖추는 것이 도움이 됩니다. [음주 중단] 음주는 불면과 우울에 악영향을 끼치니 금주를 권고드립니다.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 혈액검사 : CBC, TFT, LFT
- ② 정신과적 면담 : 미네소타 다면인성검사(MMPI), 우울척도검사(BDI)
- ③ Chest X-ray, EKG, Brain MRI

❖ 치료 계획

- ① 증상 심하고 자살 위험 시 입원 치료 권유
- ② MDD : 약물 치료(SSRI, TCA), 행동 치료, 정신 치료
- ③ BPD : 리튬+haloperidol, carbamazepine, valproate acid, lamotrigine
(우울 삽화 시 TOC)
- ④ 전기경련요법, 정신사회적 치료
- ⑤ 갑상샘 기능 저하 : Levothyroxine

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 우울증 및 치료에 대한 교육 : 우울증은 치료를 받아야 하는 병이며, 우울증 약은 중독되지 않는다. 최소 2~3주는 지나야 효과가 나오므로 중간에 끊지 않아야 한다. 증상 호전 후에도 6개월 이상 복용해야 재발을 막을 수 있다.
- ② 필요 시 입원해야 함을 강조 : 증상이 심하거나 자살의 위험이 있는 경우, 내과적 병발 질환이 있는 경우 자신과 타인의 안전을 위해서 입원 치료가 필요하다.
- ③ 충분히 회복하기 전까지는 일이나 의무, 책임을 맡지 않도록 하고 중대한 결정은 치료가 끝난 뒤에 하는 것이 좋다.
- ④ 가벼운 운동, 걷기, 수영 등의 운동이 기분을 호전시킬 수 있으니 권고한다.
- ⑤ 스트레스 관리는 어떻게 하세요? → 긍정적 인지 체계 필요, 건강한 해소 방법 찾기



keyword

정신과적 원인과 기질적 원인을 나누어 감별하기, 정신과적 원인의 경우 양극성 장애뿐만 아니라 적응장애, 애도 반응 감별하기, 기질적 원인의 경우 약물을 포함한 물질 사용/금단 증상 감별하기

병력 청취 : 병전 성격, 스트레스 요인 확인하기, 정신과적 증상과 인지장애 증상 여부도 확인하기, 자살 사고, 계획, 시도 여부 확인하기, 우울 증상 유발 약물(다이어트 약, 경구피임약 등) 복용력 확인하기

신체 진찰 : 맥박/혈압 확인, 갑상샘 진찰, 심음/호흡음 청진, 하지 오목 부종, 근력/감각 이상 여부 확인하기

악화 인자 : 스트레스(일과, 특별한 사건, 직업 등), 최근 분만력, 계절 변화

환자 교육 : 약물 치료와 정신 치료 두 가지 측면에서 치료 교육하기, 약물 부작용과 6개월 이상 꾸준한 복용 필요 교육하기, 운동/스트레스 회피/금주 교육하기

응급 상황 교육 : 자살 위험성이 높거나 정신과적 증상 동반 시 입원 권고하기